

FORMATION SYNDICALE CGT

Handicap & emploi

AGEFIPH • OETH • RQTH • maintien dans l'emploi

CGT Occitanie

Définition du handicap

«Limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société, subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant.»

Source : dictionnaire Le Robert

Mots-clés

Limitation

restriction

subie

altération

trouble

invalidant

Le handicap en chiffres

20 %

de la population vit avec
un handicap

40 %

en incluant les handicaps
temporaires

80 %

des handicaps sont
invisibles



en hausse avec le
vieillissement de la
population

C'est quoi une personne « normale » ?

Le port de lunettes est un outil de compensation : voir moins bien, c'est un handicap.

1 On donne les outils nécessaires pour fonctionner.

2 Avec l'aide technique, je me sens normal.

Quelle différence entre être normal et se sentir anormal ?

Se sentir normal, c'est être satisfait de l'expérience que l'on est en train de vivre.

Handicap et inclusion



En synthèse

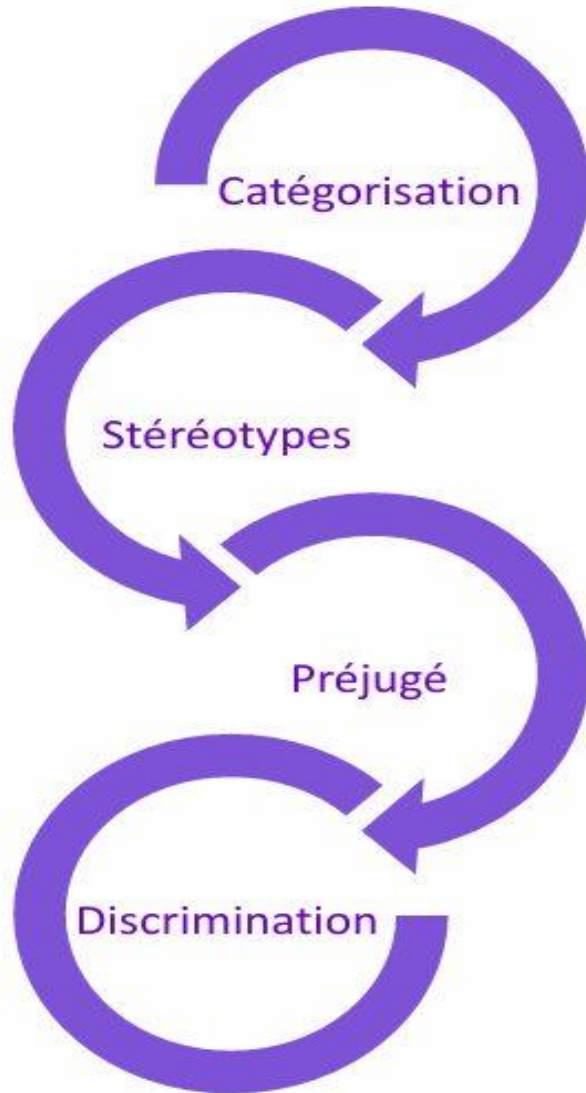


Image flickr.com

1 DÉFINITION

La conception universelle

Concevoir dès le départ :

- des lieux
- des services
- des outils
- des objets du quotidien
- des formations

pour qu'ils soient accessibles
au plus grand nombre.

→ Sans adaptation
supplémentaire.

EXEMPLE CONCRET

Une porte automatique
large utilisable par tous :
fauteuil roulant, parent
avec poussette, personne
chargée.



2 LES OBJETS DU QUOTIDIEN

Concevoir utile pour tous

De nombreux objets appliquent déjà
la conception universelle.



Télécommande avec
gros boutons lisibles
→ utile pour seniors,
malvoyants, enfants.



Essoreuse à salade
à bouton presseur
→ moins d'effort
qu'une manivelle.



Épluche-légumes à
manche ergonomique
→ meilleure prise en main,
moins de douleur.



Poignée de porte à levier
→ plus simple qu'une
poignée ronde.

3 L'UNIVERSALITÉ

Un bénéfice collectif

Ce qui aide certaines personnes
aide souvent tout le monde.



Gros boutons
= lecture plus rapide
et plus facile.



Bouton presseur
= geste plus simple,
moins de fatigue.



Manche ergonomique
= confort d'utilisation
pour tous.



Texte clair
= compréhension
immédiate pour tous.

4 À LA MAISON

Habitat inclusif

Des aménagements utiles pour tous les
habitants, à tous les âges.

Robinet mitigeur
facile à tourner



Douche
de plain-pied



Interrupteurs
larges et visibles



Rangements
à hauteur
accessible



Éclairage
automatique



5 EN ENTREPRISE

Application au travail

- poste réglable en hauteur
- clavier ergonomique
- logiciel accessible
- siège adaptable
- documents lisibles

EXEMPLE CONCRET

Une souris ergonomique
réduit la fatigue pour
tous les salariés.



Ajustable



Ergonomique



Accessible



Lisible

6 CHANGER DE LOGIQUE



Créer un objet standard
puis corriger après



Concevoir un objet pratique
pour tous dès le départ



EXEMPLE CONCRET

Créer directement une télécommande
simple, lisible et intuitive.

7 CONCLUSION

Résumé

Conception universelle :
penser pour tous dès l'origine.



Universalité :
permettre à chacun d'utiliser
le même service avec autonomie
et dignité.



EXEMPLE GLOBAL

Une gare avec ascenseurs, annonces sonores,
écrans lisibles et signalétique claire aide
tous les voyageurs.



8 SOURCE



Agefiph – Ressources sur l'accessibilité
et la conception universelle.



L'inclusion du handicap
fait progresser les entreprises
et la société tout entière.

Conclusion

Conception universelle

Penser pour tous dès l'origine.

Mais ce n'est pas suffisant.

Conception universalisante

Une innovation née d'un besoin précis...

... qui améliore l'usage pour chacun.

Société et transition inclusive

La réussite de l'inclusion repose sur le rapprochement de deux acteurs.

Entreprises (privé / public)

Embauche et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Secteur spécialisé (ESMS)

Parcours alternatif et soutien pour monter en compétences et accéder à l'emploi.

L'objectif est de favoriser les passerelles entre ces différents univers.

Droit commun — transition inclusive

L'enjeu

Aider les entreprises à percevoir les bénéfices du recrutement des personnes en situation de handicap.

Le droit commun c'est permettre à chacun d'accéder aux mêmes dispositifs, aux mêmes formations et aux mêmes opportunités professionnelles.

Droit commun désigne le cadre général s'appliquant à l'ensemble des citoyens, par opposition à des dispositifs spécifiques ou isolés.

Lexique

RQTH

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

BOETH

Bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

OETH

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

DOETH

Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés

FIPHFP

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique



Le handicap, la situation de handicap

Qu'est-ce que le handicap ?

La définition du handicap dans la loi de 2005

Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi 2005-102)

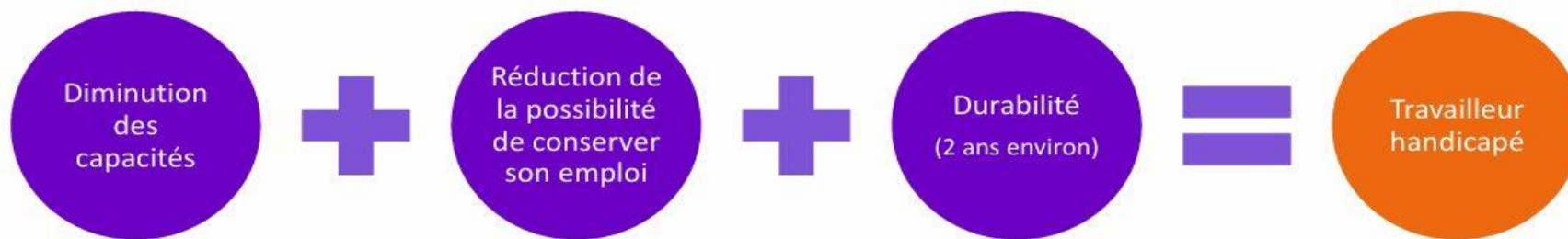
« Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société **subie dans son environnement** par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » .

Qu'est-ce qu'un travailleur handicapé ?

La définition légale du travailleur handicapé

La définition du travailleur handicapé est dans le code du travail (L323-10)

« Toute personne dont les possibilités d'obtenir de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ».



Les fondamentaux de la loi Handicap

Les fondements : les grandes lois

1916

- Instauration de lois pour les mutilés de guerre et des emplois réservés après leur retour du front



1987

- 10 juillet : loi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés avec l'instauration du taux d'emploi de 6%
- Création de l'Agefiph



2018

- 5 septembre : loi pour les libertés de choisir son avenir professionnel.
- Implique des modifications de l'OETH à partir du 1 janvier 2020

La loi privilégie l'emploi direct de personnes en situation de handicap



1975

- 30 juin : texte de référence instaurant la politique publique sur le handicap
- Définition des 3 droits fondamentaux : droit au travail, minimum de ressources et intégrations scolaire et sociale
- Création de la COTOREP



2005

- 11 février : loi pour l'égalité des droits et des chances et la citoyenneté des personnes handicapées.
- Apporte une définition légale du handicap
- Extension de l'obligation de 6% au secteur public et création du FIPHFP.

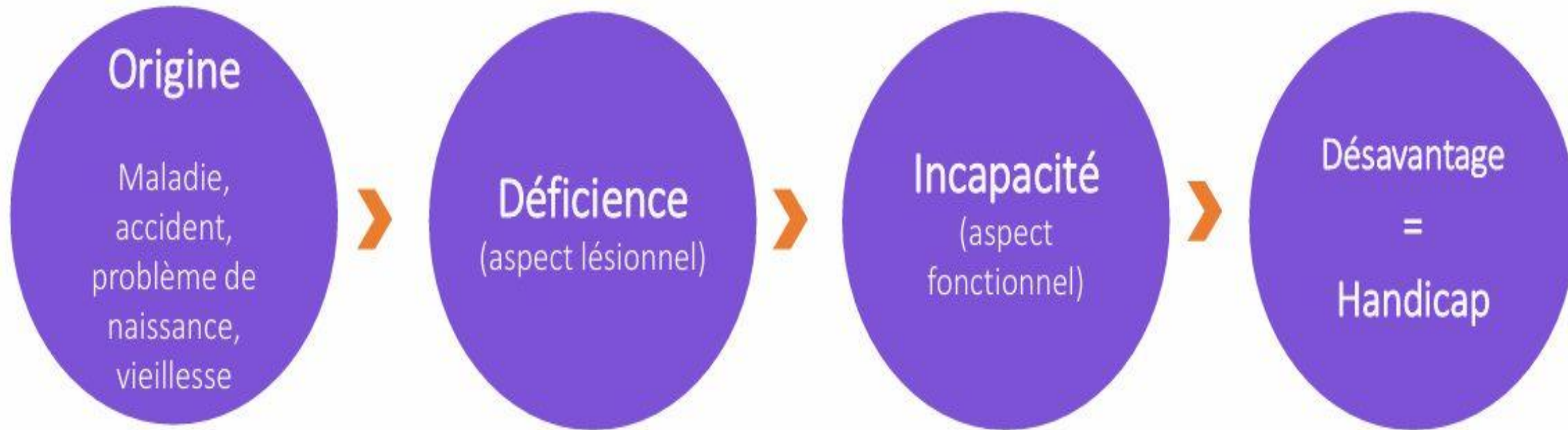


2024

- Loi plein emploi :
 - Meilleur accompagnement des demandeurs d'emploi (France Travail, Cap emploi)
 - Priorité au milieu ordinaire (orientation en ESAT par les MDPH sur préconisation de France Travail après un bilan avec la personne).
 - De nouveaux droits/RQTH (équivalence de RQTH pour les jeunes en situation de handicap)



La définition traditionnelle du handicap



La situation de handicap



La notion de situation de handicap

Le handicap n'est pas un fait en soi, mais la combinaison d'un trouble de santé face à une situation donnée

On parle de situation de handicap



Un comptable déficient visuel utilisant un nouveau logiciel sans synthèse vocale



Un employé Libre-Service sourd dans une réunion d'équipe



Un magasinier asthmatique travaillant dans un local confiné

Connaissances de base du handicap au travail

1 De la catégorisation à la discrimination

2 Le handicap, la situation de handicap

3 Les différents types de handicap

4 Les fondamentaux de la loi Handicap – Zoom RQTH

Ces connaissances sont indispensables pour agir efficacement dans l'entreprise.



Les différentes familles de handicap

Les « familles » de handicap



**HANDICAP
MOTEUR**



**MALADIES
INVALIDANTES**



**HANDICAP
PSYCHIQUE**



**HANDICAP
AUDITIF**



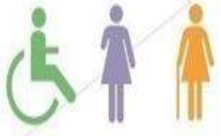
**HANDICAP
MENTAL**



**HANDICAP
VISUEL**



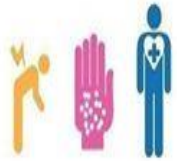
**HANDICAP
COGNITIF**



Déficiences motrices

La déficience motrice recouvre l'ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs.

Lombalgie, TMS, rhumatisme, AVC, hémiplégie, myopathie, hernie discale, malformation, paralysie...



Maladies chroniques évolutives ou invalidantes

Ces maladies entraînent une restriction d'activité (motrice, quantité de travail à réaliser, durée ou l'intensité pour l'accomplir...). Certaines sont évolutives, c'est-à-dire que l'état de santé de la personne va se dégrader.

Hypertension, insuffisance cardiaque, diabète, eczéma, cancer, épilepsie, allergies, maladie de Crohn...



Déficiences visuelles

La déficience visuelle a de nombreuses origines (congénitales, due à une maladie ou un accident). Elle se caractérise par une perte de l'acuité visuelle (vision floue ou réduite, absence de relief, sensibilité à la lumière...) pouvant aller jusqu'à la cécité.

Myopie, presbytie, strabisme, rétinite, daltonisme...



Déficiences auditives

La perte auditive totale est rare et la plupart des déficients auditifs possèdent des « restes » auditifs. Elle se caractérise par une difficulté voire une impossibilité à percevoir et localiser les sons et la parole.

Acouphène, surdité légère à profonde...

Différencier le handicap mental/cognitif/psychique



Déficiences mentales ou intellectuelles

La déficience intellectuelle se traduit par une difficulté à comprendre et une limitation de la rapidité des fonctions mentales. La personne a un niveau de Quotient Intellectuel (QI) très inférieur à la moyenne, en dessous de 70.

Trisomie 21, syndrome x fragile...



Déficiences cognitives

Lorsque seules certaines fonctions cognitives sont touchées, n'entraînant pas forcément une réduction globale du niveau intellectuel.

Troubles DYS, Troubles d'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA)...



Déficiences psychiques ou maladies mentales

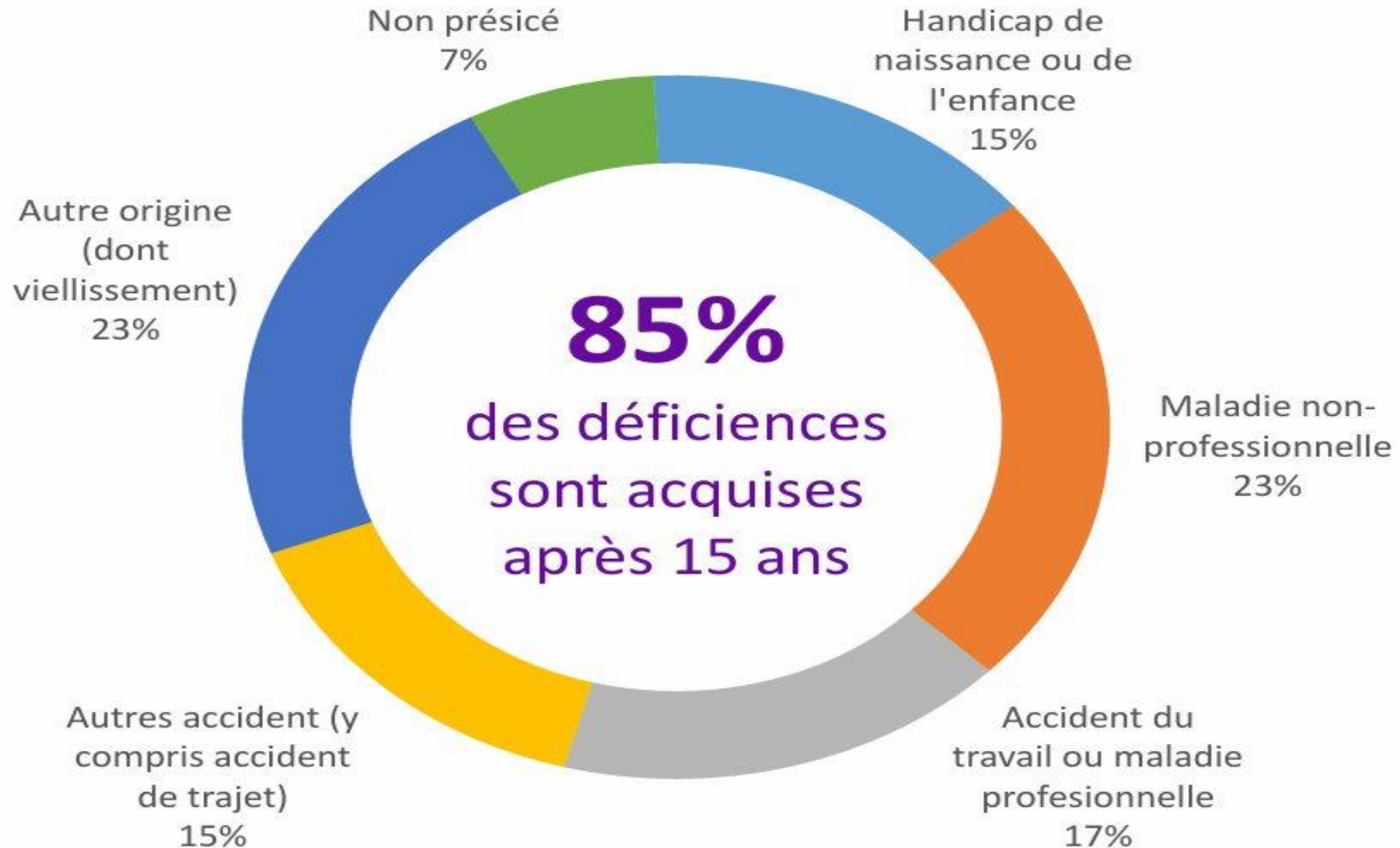
C'est la conséquence de maladies mentales entraînant un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une grande variabilité dans la possibilité d'utilisation des capacités alors que la personne garde des facultés intellectuelles dites normales.

Psychoses, Névroses, Troubles de la personnalité, troubles de l'humeur, troubles des conduites alimentaires, TOC, phobies, addictions, dépression...

Visibilité du handicap



Handicaps acquis ou innés ?



3%

des personnes
en situation de
handicap sont
en fauteuil



Exemples de pathologie, incapacités et modalités de compensation

Déficiences	Pathologie	Conséquence, limitation	Compensation
Moteur / Physique	Dorsalgies	Porter des « charges »	Adaptations techniques : aides à la manutention. Aménagements organisationnels (pauses, rythmes de travail, horaires)
Maladie invalidante	Cancer	Fatigabilité	Prévoir des phases de repos, Sensibiliser le collectif
Psychique	Dépression	Porter un regard juste et distancié sur soi et ses compétences	Attitude empathique, Rappeler le cadre, la réalité des choses « sans déformation »
Sensoriel / auditif	Acouphènes	Fatigabilité (dans un environnement bruyant par exemple)...	Privilégier les supports écrits et les phrases simples, schémas, dessins..., Sensibiliser le collectif
Sensoriel / Visuel	Champ visuel altéré	Se déplacer, se repérer dans l'espace	Repères sonores ou tactiles/podo-tactiles
Cognitif / Dys	Dysorthographe	S'exprimer par écrit	Privilégier l'utilisation de logiciels adaptés

Les modalités de compensation du handicap

Technique

- Prothèse auditive
- Fauteuil ergonomique
- véhicule adapté
- Etc...

Organisationnelle

- Temps partiels
- Rotation des équipes
- Répartition des tâches
- Etc...

Managériale

- Mise en place d'un entretien régulier de suivi
- Objectifs adaptés
- Etc...

Formation

- Reconversion professionnelle
- Langue des signes
- Etc ...

La RQTH

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

RQTH simplifiée (Loi du 5 septembre 2018)

La reconnaissance du handicap simplifiée

La RQTH peut être
attribuée à vie

- La RQTH peut être attribuée à **vie** si le handicap est jugé irréversible (sinon la RQTH est attribuée pour une durée de **1 à 10 ans, renouvelable**).

Une RQTH délivré
automatiquement

- La carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention *invalidité* et l'allocation adulte handicapé (AAH) ouvrent droit au statut de travailleur handicapé sans la moindre démarche supplémentaire

un délai pour éviter les
ruptures de droit

- Lors du renouvellement les effets de la précédente RQTH sont prorogés de **4 mois** sous réserve que la demande ait été faite avant échéance

DEPUIS 2024 Les jeunes de 15 à 20 ans ayant déjà un dossier à la **MDPH** (*allocation d'éducation de l'enfant handicapé, plan personnalisé de scolarisation...*) seront dispensés de faire un dossier de demande de RQTH ; elle leur sera attribuée automatiquement. Ils pourront donc bénéficier sans délai des droits et dispositifs emplois ouverts aux personnes handicapées. <https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/ce-qui-change-au-1er-janvier-2024>

Zoom RQTH : démarches et éléments pour convaincre

Diversité des titres administratifs

Être bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi de Travailleur Handicapé (BOETH)

MDPH

(Maison Départementale des personnes handicapées)

Reconnaissance de la Qualité de
Travailleurs Handicapé (**RQTH**)

Carte Mobilité Inclusion (**CMI**)
avec mention « invalidité »
(ex -Carte d'invalidité)

Allocation Adulte Handicapé
(**AAH**)

Assurance Maladie

Pension d'invalidité
(si invalidité réduit au moins de
2/3 ses capacités de travail)

**Victimes accident du travail
/maladie professionnelle**
entraînant une
Incapacité Permanente Partielle
(IPP) $\geq 10\%$ et percevant rente

Code des pensions militaires et des victimes de guerre

Pension militaire d'invalidité

Sapeurs-pompiers volontaires
titulaires allocation/rente
d'invalidité pour
accident/maladie en service

En résumé : Les freins côté personne handicapée (1/3)

«Les collègues seront au courant et mon problème ne vous regarde pas»



- Obligation de confidentialité de l'employeur et le cas échéant seules les incidences sur l'activité professionnelle sont abordées

« Si j'ai une RQTH, on va refuser de m'assurer pour un prêt pour l'achat de mon appartement »

- La RQTH et les éléments du dossier sont confidentiels. Seuls le salarié et la MDPH en ont connaissance.
- Dans le cadre d'un prêt bancaire, seul le questionnaire de santé est à rendre, sans qu'on y demande si on est titulaire d'une RQTH. En aucun cas la RQTH est un frein à l'acceptation d'un prêt, seule la pathologie peut entraîner une surcote ou un refus des assureurs de prêt.

En résumé : Les freins côté personne handicapée (2/3)



«On va me changer de poste, je risque de perdre mon emploi»

- Au contraire, l'entreprise est engagée pour favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
- L'employeur ne peut pas licencier un salarié du fait de son handicap.
- La RQTH permettra au contraire d'œuvrer pour trouver des moyens de compensation du handicap (Aides financières pour l'aménagement du poste, mobilisation d'experts...).
- Le handicap ne limite pas la compétence professionnelle ; certaines reconversions peuvent même s'accompagner d'une promotion professionnelle.

En résumé : Les freins côté personne handicapée (3/3)



« Je n'en tirerai aucun avantage financier » ou « qu'est-ce que ça va m'apporter à moi !? »

- Accéder à des aides ou prestations pour adapter et compenser,
- Recourir à Cap Emploi pour aider à la recherche de solutions,
- Bénéficier d'un suivi médical adapté par le médecin du travail,
- Accéder aux aides pour sa réorientation et sa reconversion professionnelle,
- Une majoration du CPF de 300€ par an (en plus des 500€),
- Sous certaines conditions, une retraite anticipée.
- Evoquer le fait que l'entreprise (établissement de plus de 20 salariés) est soumise à une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés.

Pour résumer...

La RQTH c'est quoi ?

La **R**econnaissance de la **Q**ualité de **T**ravailleur **H**andicapé est attribuée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

C'est le fruit d'une démarche volontaire, individuelle, confidentielle et qui ne relève pas d'informations médicales transmises aux employeurs ou à d'autres organismes

?

Une RQTH , pour qui ?

Tout salarié souffrant de problème de santé (physique, sensoriel, mental, psychique,...) ou d'une maladie chronique (diabète, asthme, sclérose en plaque,...) ayant des répercussions sur les possibilités d'occuper son poste.

Une RQTH , pourquoi ?

Elle permet de mobiliser, si nécessaire, des mesures pour favoriser le maintien dans l'emploi et prévenir la désinsertion professionnelle

Pour le salarié :

- Adaptation de sa situation de travail
- Aide au reclassement ou à une réorientation professionnelle
- CPF majoré (+300€)*
- Sous condition prise en compte pour la retraite**

Pour l'employeur :

- Répondre à son obligation d'emploi
- Bénéficier d'aides, prestations et services pour faciliter le maintien du salarié

Zoom CPF

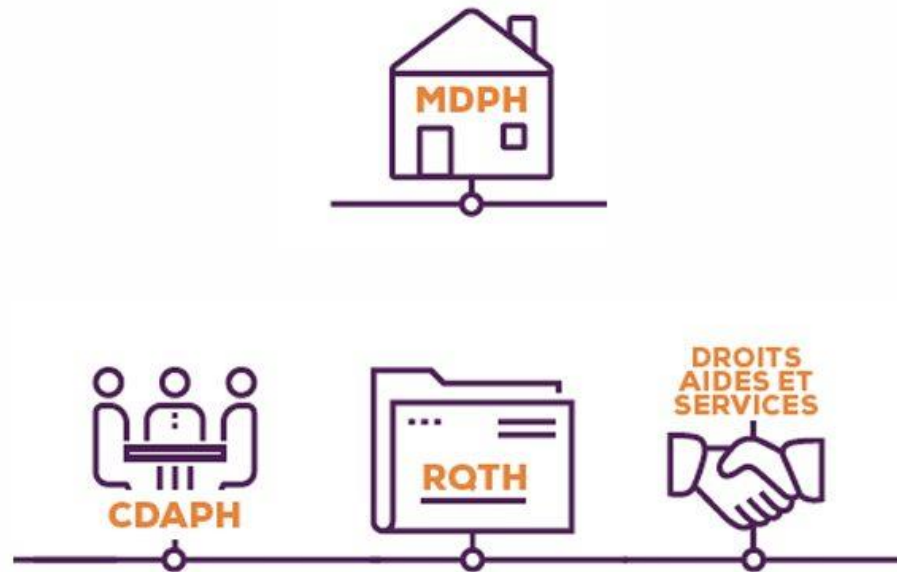


Pour le Compte Personnel de Formation (CPF), les salariés ont le droit à 500 €/ an avec une **majoration de 300 € / an pour les salariés ayant une reconnaissance administrative du handicap**

- « Vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et à ce titre, une majoration de 300 € de droits de formation pourra vous être accordée. Cette disposition mise en place depuis 2019 ne concerne que les salariés. Vous pouvez renseigner votre situation liée à un handicap dans la rubrique Informations professionnelles du portail et l'application mobile *MonCompteFormation*.
- Ces renseignements ne seront utilisés que dans le cadre strict de l'alimentation de vos droits de formation et ne seront transmis ni à votre employeur, ni à aucune autre administration. **Si vous avez indiqué votre situation à votre employeur, cette information est automatiquement récupérée depuis 2021 et il n'est pas nécessaire de déclarer sur le portail ou l'application mobile. »**

<https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/consulter-mes-droits-formation>

Du dépôt de dossier à la RQTH



 agefiph

**CAP
EMPLOI**
Handicap, recrutement & maintien

Comment formuler une demande de RQTH ?

DEMANDE À LA MDPH

Article R.146-26 du code de l'action sociale et des familles
La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées.
Elle étudie votre situation pour répondre aux besoins liés à votre handicap.
Ce formulaire se dépose progressivement sur le service national until le 1^{er} septembre 2017 et le 1^{er} mai 2018.
À compléter : il est substitué définitivement au formulaire Cerfa 13758*01.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

À qui s'adresse ce formulaire ?

Ce formulaire s'adresse à la personne présentant un handicap.

Si la personne concernée a moins de 18 ans, ses parents sont invités à répondre pour elle.

Si la personne de plus de 18 ans a une mesure de protection, son tuteur répond avec elle ou son curateur l'accompagne dans sa demande.

Pour obtenir de l'aide pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous adresser à l'accueil de la MDPH.

Vous allez expliquer à la MDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes.
En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être bénéficier des droits suivants :

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) voire un de ses compléments	Renouvellement d'allocation compensatrice (ACTP ou ACFP)
Allocation aux adultes handicapés (AAH) voire un de ses compléments	Projet personnalisé de scolarisation – parcours et aides à la scolarisation
Carte mobilité inclusion (anciennement carte d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées)	Orientation professionnelle et/ou formation professionnelle
Orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) enfants/adultes	Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Prestation de compensation du handicap (PCH)	Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

Que dois-je remplir ?

C'est ma première demande à la MDPH Ma situation médicale, administrative, familiale ou mon projet a changé Je souhaite une réévaluation de ma situation et/ou une révision de mes droits	Remplissez tout le formulaire pour exprimer l'ensemble de vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de préciser les droits et prestations que vous souhaitez demander en remplissant la partie E
Je souhaite le renouvellement de mes droits à l'identique car j'estime que ma situation n'a pas changé	Remplissez les parties A et E. Vous avez aussi la possibilité de remplir tout le formulaire
Votre aidant familial (la personne qui s'occupe de vous au quotidien) souhaite exprimer sa situation et ses besoins	Votre aidant familial peut remplir la partie F

Vous avez déjà un dossier à la MDPH ?

Oui Dans quel département : N° de dossier :



Certificat médical

A joindre à une demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Articles R.146-26 et D.245-25 du code de l'action sociale et des familles. Ce certificat est un document obligatoire et essentiel pour permettre à la MDPH d'orienter et d'attribuer allocations et prestations à la personne en situation de handicap. Il peut être téléchargé et complété sous forme papier ou rempli en ligne avant d'être imprimé.

À l'attention du médecin

Ce certificat médical, et les éventuels documents complémentaires, sont à remettre à votre patient, pour qu'il les joigne, sous pli confidentiel, à son dossier de demande à la MDPH.

- Il est destiné à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH qui a besoin de recueillir des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap* de votre patient, en apportant un soin particulier au retentissement fonctionnel.
- Nous vous recommandons de conserver une copie du présent formulaire de certificat médical. Les professionnels de la MDPH restent à votre disposition.

Depuis votre précédent certificat médical :

État de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a-t-il changé ?	Oui	Non
Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, orientation personnelle, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?	Oui	Non
La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y compris ses conséquences : médicales ou par médicaments ; appareillage) a-t-elle été modifiée ?	Oui	Non

* « Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » (Article L.144 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005)

Si vous avez répondu oui à au moins une de nos questions veuillez remplir la totalité du certificat médical. Dans le cas contraire vous pouvez remplir le certificat médical simplifié ci-dessous :

Je soussigné Docteur certifie qu'il n'y a aucun changement dans la situation de M. ou Mme depuis mon précédent certificat.

Date :
Signature :

À l'attention du patient

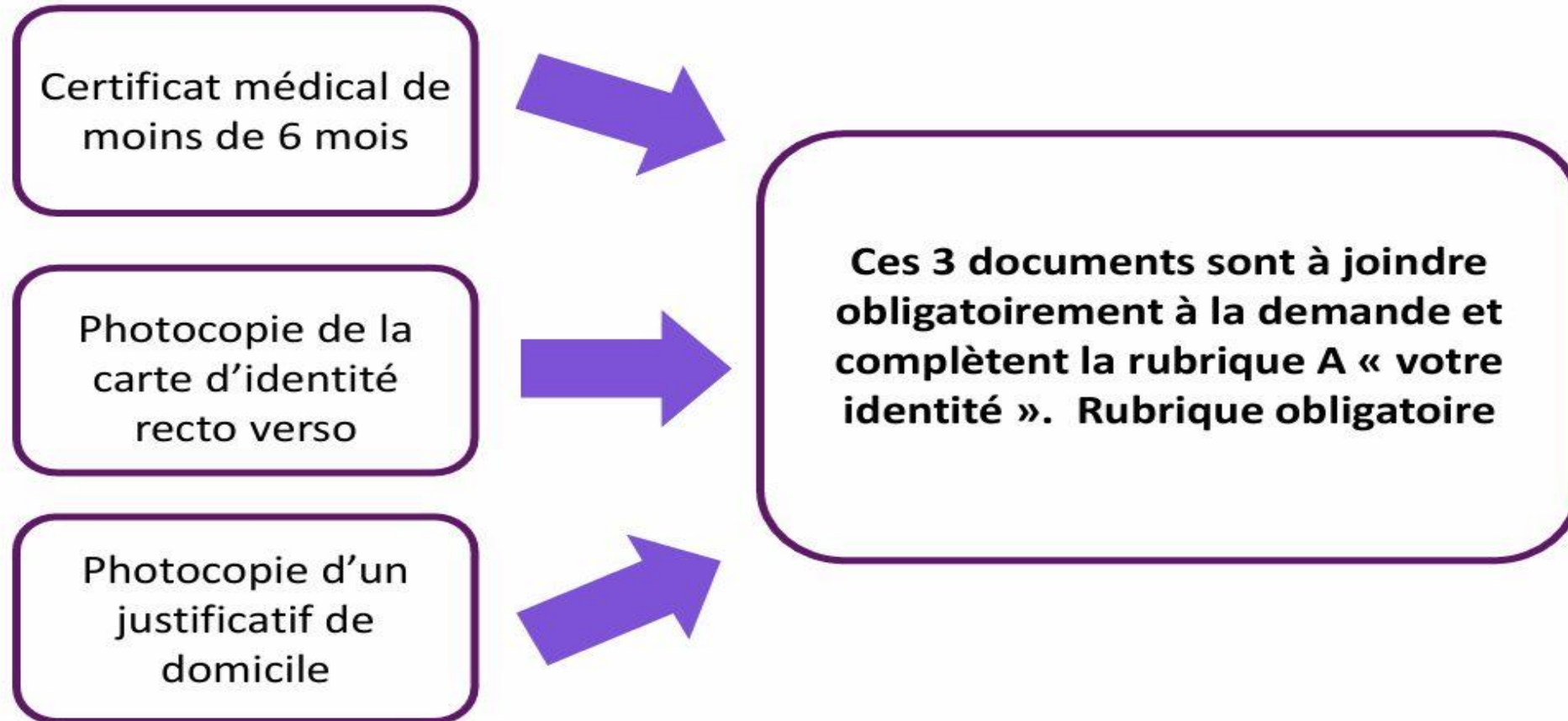
Merci d'aider votre médecin en remplissant les éléments ci-dessous :

Nom de naissance : Nom d'usage :
Prénom : Date de naissance :
Adresse :
N° d'inscription sécurité sociale : N° de dossier auprès de la MDPH :
Quels sont les principaux besoins et attentes exprimés dans votre demande à la MDPH ?

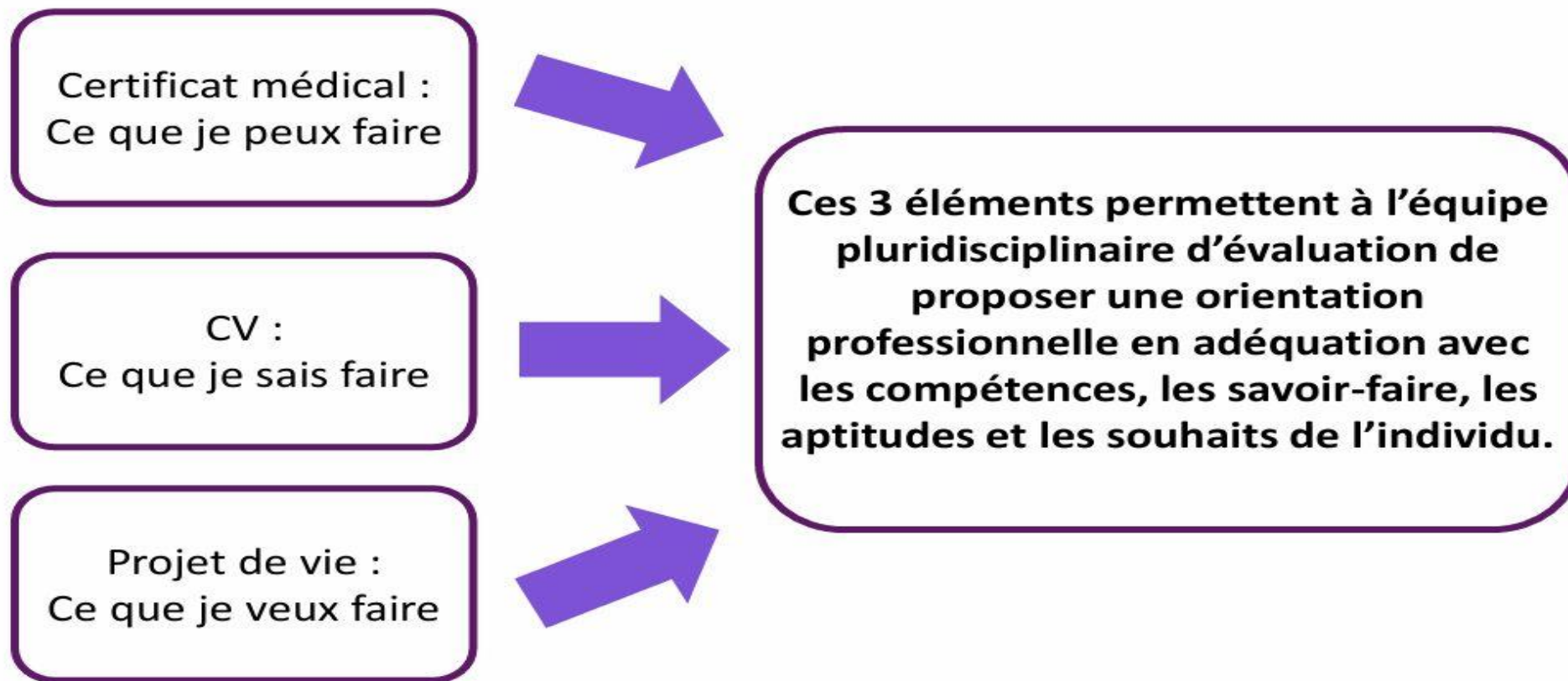
A joindre à ce document

Si des examens complémentaires, évaluations ou hospitalisations en lien avec le handicap ont été réalisés, le mentionner dans ce formulaire aux rubriques concernées, et joindre les comptes-rendus et documents les plus significatifs. Ces documents sont à joindre par le médecin et/ou le patient.

Les pièces administratives obligatoires



Les éléments administratifs importants



Pour « bien » répondre

Les bons réflexes en tant qu'entreprise

- Bien être identifié.e auprès des collaborateurs, managers et IRP comme personne ressource sur ce sujet.
- S'être présenté au médecin du travail et son équipe et avoir défini les rôles dans l'accompagnement vers la RQTH.
- Se former et s'informer sur les démarches.

Les éléments clés à partager avec le salarié

- Expliquer le déroulement de l'instruction du dossier RQTH.
- Expliquer que la RQTH est une reconnaissance que l'état de santé de la personne a des conséquences sur le quotidien au travail => aménager pour compenser.
- Permet d'avoir accès à des aides et prestations individuelles pour adapter le travail en fonction de l'état de santé de la personne.
- Assure une adaptation du poste de travail en lien avec le manager.



Le taux d'incapacité

Le taux d'incapacité, ça vous parle ?

Ce taux est pris en compte dans la procédure d'attribution de certaines aides et prestations sociales par la Commission Départementale des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), par exemple pour décider de l'attribution de la carte d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, ou encore de la carte mobilité inclusion (mais pas la RQTH qui sera abordée plus loin).

Le taux d'incapacité est déterminé par le niveau des conséquences du handicap dans la vie des personnes (vie scolaire, professionnelle, sociale, domestique).

Un taux, c'est un pourcentage ? Il faut faire des maths ?

Ce taux est calculé par une équipe pluridisciplinaire à partir, entre autres outils, d'un « guide barème » qui permet de déterminer 3 fourchettes de taux d'incapacité :

- Taux d'incapacité inférieur à 50 % : il correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
- Taux d'incapacité entre 50 % et 79 % : il correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable entravant effectivement la vie sociale de la personne.
- Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % : troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

La pension d'invalidité

La pension d'invalidité est un revenu de remplacement versé par l'Assurance maladie pour compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant d'une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle.

Elle prend le relais, le plus souvent, d'indemnités journalières versées durant un arrêt de travail.

Comment est calculé son montant, me demandez-vous ?

Son montant dépend des revenus antérieurs sur lesquels des cotisations ont été versées et de la catégorie d'invalidité.

Mais, est-elle obtenue pour la vie ?

Non, elle est temporaire, révisable et imposable

Qui décide, c'est la personne elle-même ?

Si elle répond aux critères d'éligibilité et si son médecin traitant ou le médecin du travail le lui conseille, elle peut faire une demande de pension d'invalidité.

Également, la caisse d'assurance maladie peut déclencher la procédure, notamment si la personne perçoit des indemnités journalières depuis trois ans, ou, si le médecin-conseil estime, suite à un contrôle, son état stabilisé et sa capacité de travail et de gain réduite au moins des deux tiers.

Pour aller plus loin

Un site internet dédié



www.travailleurhandicapé.fr

Outils de communication Agefiph



Flyers entreprise et salarié



« votre l'emploi aux personnes handicapées »

Faut-il parler de son handicap à son (futur) employeur? Quelle est la meilleure manière de l'aborder? Le moment opportun? Voici nos conseils, pour vous aider à faire les bons choix.



<https://www.activateurdeprogres.fr/sites/default/files/2021-06/Comment aborder le handicap avec%20son%20responsable WEB personnalisable.pdf>

<https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-08/AGEFIPH-DEPLIANT-Faire-connaître-son-handicap WEB-personnalisable.pdf>

Une campagne
d'affichage



« Tu vois ce que je veux dire ? »

Cécité, surdité, acouphènes...
Les handicaps sensoriels se traduisent
par des difficultés plus ou moins importantes
à voir ou à entendre.

**VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE
EN SITUATION DE HANDICAP.**

Le service des ressources humaines ou la mission handicap sont à votre
disposition pour trouver et mettre en œuvre les solutions qui vous permettront
de concilier votre emploi avec votre état de santé.

 **agefiph** ouvrir l'emploi
aux personnes handicapées  www.agefiph.fr
1 9 6 0

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichier/s/2019-10/CAMPAGNE-RQTH-A3_03_0.pdf



« Je donne ma langue au chat »

Troubles dys, autisme...
Les handicaps cognitifs se traduisent
par des difficultés à acquérir
et à traiter des informations.

**VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE
EN SITUATION DE HANDICAP.**

Le service des ressources humaines ou la mission handicap sont à votre
disposition pour trouver et mettre en œuvre les solutions qui vous permettront
de concilier votre emploi avec votre état de santé.

 **agefiph** ouvrir l'emploi
aux personnes handicapées  www.agefiph.fr
1 9 6 0

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/CAMPAGNE-RQTH-A3_04_0.pdf



« Toi tu as encore fait la fête hier ! »

Cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires...
Les maladies invalidantes peuvent nécessiter
des soins réguliers et engendrer douleur,
effets secondaires et fatigabilité.

**VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE
EN SITUATION DE HANDICAP.**

Le service des ressources humaines ou la mission handicap sont à votre
disposition pour trouver et mettre en œuvre les solutions qui vous permettront
de concilier votre emploi avec votre état de santé.

 **agefiph** ouvrir l'emploi
aux personnes handicapées  www.agefiph.fr
1 9 6 0

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/CAMPAGNE-RQTH-A3_02.pdf

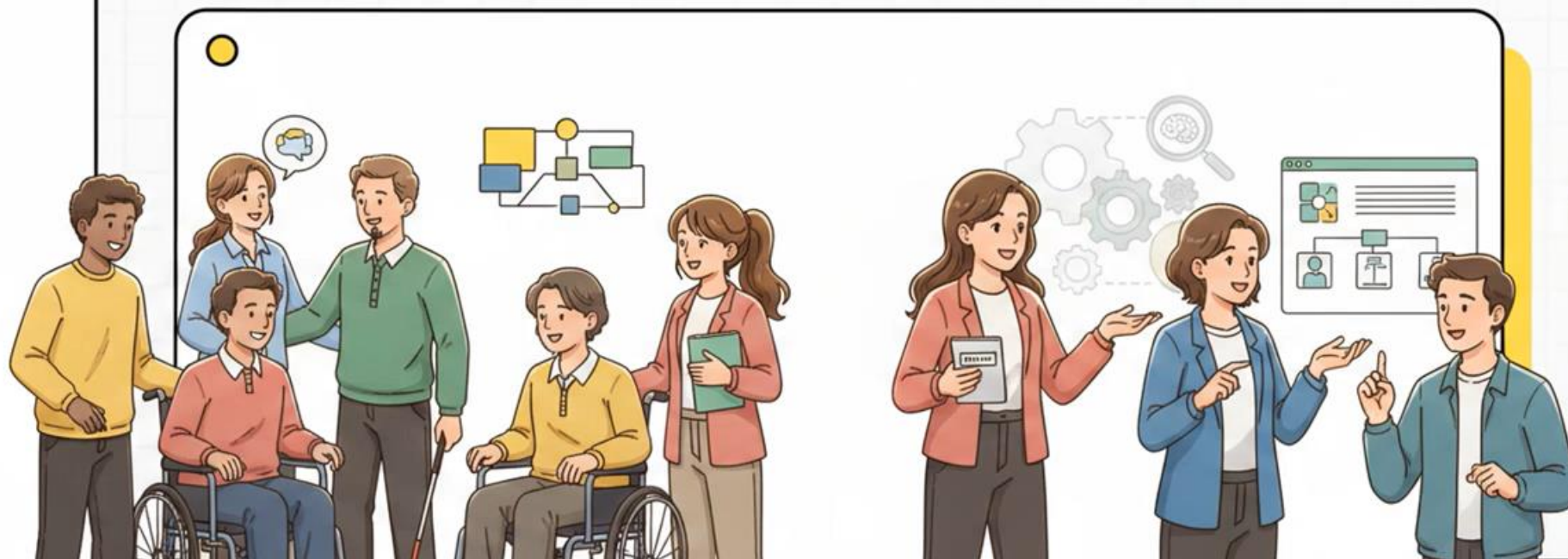
Liens utiles

- ✓ Formulaire RQTH et vidéo : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993>.
- ✓ Formation : <https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-personnes-en-situation-de-handicap/>.
- ✓ CPF : <https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/droits>
- ✓ Retraite anticipée : <https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F16337>
- ✓ Comment aborder la RQTH : https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/AGEFIPH_FICHE_RRH-Comment%20aborder%20la%20RQTH.pdf.
- ✓ FAQ MDPH : consultez la foire aux questions sur le site www.handicap.gouv.fr.
- ✓ Télé service MDPH : <https://mdphenligne.cnsa.fr>.
- ✓ Défenseur des droits - [Guide "Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable"](#)

Référent handicap en entreprise

- Sensibilisation
- Accompagnement
- Coordination

Le Référent Handicap



Obligatoire ou pas ?

La **loi** pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(5/09/2018)

- ➔ désignation d'un **réfèrent handicap** au sein de toute entreprise employant au moins 250 salariés
- ➔ Les entreprises de moins de 250 salariés sont *invitées* à désigner un réfèrent handicap mais pas d'obligation.

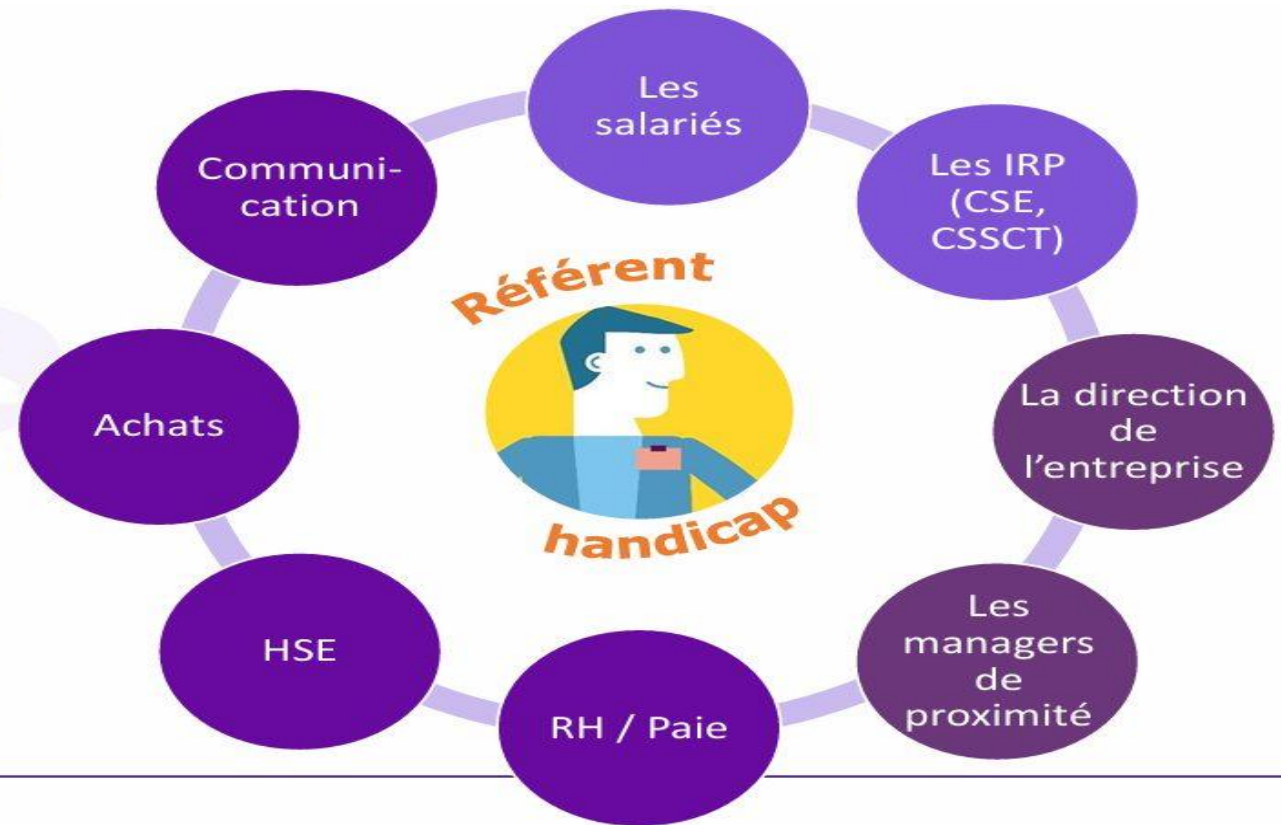
Le rôle du référent handicap défini par la loi

L'article L5213-6-1 du Code du travail précise que le référent handicap est :

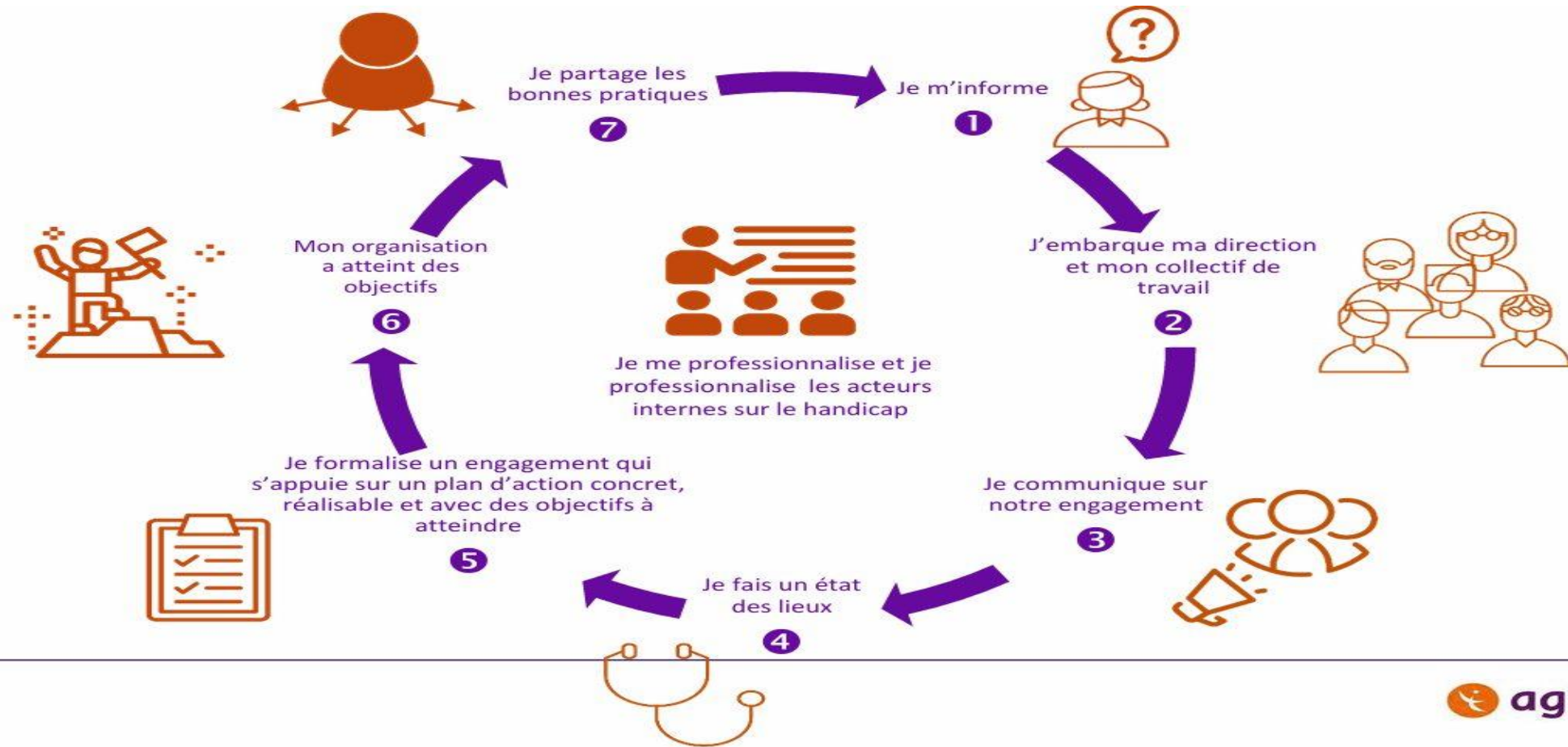
« chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap »

Les acteurs de l'entreprise impliqués dans la politique handicap

Les acteurs de l'entreprise impliqués dans la politique handicap



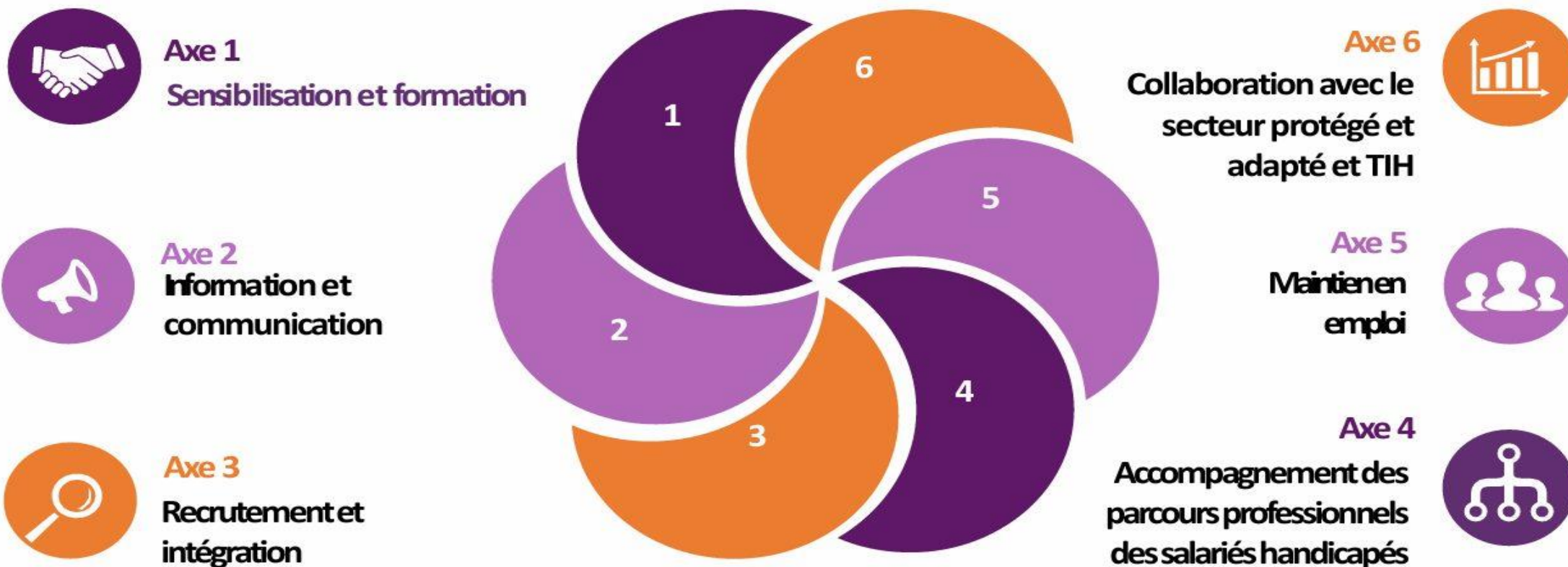
En synthèse



Existe-t-il une politique handicap dans votre entreprise ?



Les axes structurants d'une politique handicap



Pour la plupart des actions il existe des dispositifs et des aides financières de l'état et de l'Agefiph pour vous appuyer dans la mise en œuvre de ces actions.

Voici une synthèse des 5 piliers d'une politique handicap efficace en entreprise

Cette structuration permet de transformer une obligation réglementaire en un véritable levier de performance sociale et de progrès collectif pour l'ensemble des salariés.

Pilier	Objectif principal	Importance et bénéfices
L'engagement de la direction	Inscrire le handicap dans la stratégie globale de l'entreprise.	C'est le point de départ indispensable qui donne de la légitimité au projet et permet de construire des actions durables.
La sensibilisation	Déconstruire les préjugés et les stéréotypes sur le handicap.	Elle permet de faire évoluer les regards et les comportements. On ne peut pas inclure sans sensibiliser le collectif de travail.
Le recrutement	Analyser les compétences des candidats plutôt que leurs limitations.	Elle favorise l'égalité des chances et permet d'ouvrir tous les postes aux personnes en situation de handicap.
Le maintien dans l'emploi	Anticiper les risques d'inaptitude et de désinsertion professionnelle.	L'objectif est de préserver l'emploi et les compétences déjà présentes dans l'entreprise dès l'apparition de problèmes de santé.
Le suivi des résultats	Définir des responsabilités, des objectifs et des indicateurs de pilotage.	L'organisation (comité de pilotage, réunions de suivi) garantit la continuité des actions et mesure l'efficacité de la politique inclusive.

Acteurs externes du recrutement/intégration

Service de santé au travail

Université et Grandes écoles

CFA



- Site internet avec offres d'emploi (CDD, CDI)
- PMSMP



- Offres d'emploi (CDD, CDI)
- PMSMP



- Site emploi avec offres d'emploi (CDD, CDI) et de stage
- Aides et prestations pour les formations et l'intégration

Associations représentant les intérêts des personnes handicapées ou gérant des établissements



Site internet avec offres d'emploi (CDD, CDI)

Entreprises d'intérim
=> EATT

Cabinets privés spécialisés

ESRP

Stages de fin de formation



=> Les Esat
- Mise à disposition
Pour certains :
Emploi accompagné



Accompagnement du public « jeune »



=> Les entreprises adaptées (EA)
- CDD Tremplin

Zoom Alternance

2 types de contrat concernés :

- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation

 **Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes handicapées**

 **Aides cumulables avec les autres aides** de l'Agefiph et les aides à l'emploi et à l'insertion professionnelle délivrées par l'Etat ou les Régions dont le dispositif parcours emploi compétences (PEC)

Axe 3 : le recrutement Les bonnes pratiques



<https://www.youtube.com/watch?v=KUj1G8-f6ao>

<https://www.youtube.com/watch?v=KUj1G8-f6ao>

L'accueil et l'intégration : Les étapes

Pour toute nouvelle recrue dont vous savez qu'elle a un titre de BOE

- La visite médicale d'information et de prévention (avant la fin de la période d'essai)

Au regard des besoins de compensation exprimés par la personne handicapée :

- L'adaptation du poste de travail (voire l'accessibilité au poste de travail s'il y a lieu)
- L'identification et la communication des consignes de sécurité
- La mise en place du tutorat
- La sensibilisation de l'équipe
- L'accueil du nouvel embauché
- Un suivi rapproché pendant la période d'intégration



Au besoin, vous pouvez solliciter l'appui d'experts externes. Des aides financières existent pour cela.

L'accueil et l'intégration : Les règles d'or

Un salarié en situation de handicap dans votre entreprise est **avant tout un salarié comme un autre**.

Comportez-vous comme vous vous comporteriez avec n'importe quelle personne.

Soyez à l'aise avec le sujet du handicap afin que votre interlocuteur le soit aussi.

Construisez un climat de confiance ce qui vous permettra d'obtenir des informations précieuses sur la façon dont la personne assume son handicap vis-à-vis des autres et vous permettra une meilleure préparation de son intégration.

Les outils de l'Agefiph

L'espace emploi Agefiph

- Y trouver des candidats
- Poster vos offres d'emploi (gratuit)

<https://espace-emploi.agefiph.fr/company/signin>

Des aides dédiées

- **Aide à l'accueil et l'intégration**
- **Aide à l'alternance**

En savoir plus :

<https://www.agefiph.fr/aides-financieres?publics=1&thematique=169>



ActivBox

Un outil de sensibilisation aux handicaps pour favoriser l'intégration de personnes handicapées dans votre entreprise

Pour y avoir accès :

<https://www.activateurdeprogres.fr/>



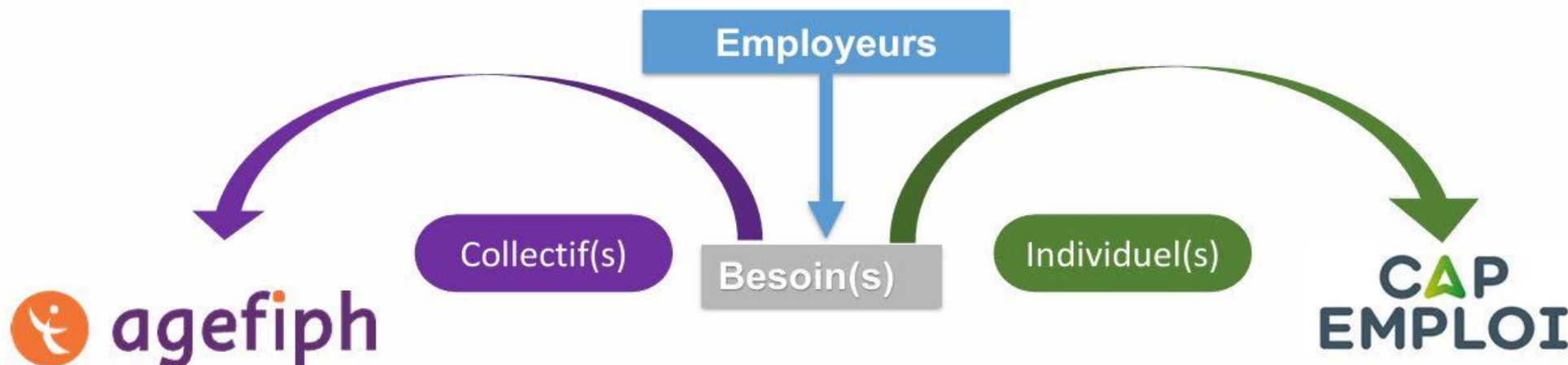
Réseau des Référents Handicap

Le Réseau des Référents Handicap

- Y rencontrer des pairs de votre secteur d'activité
- Y partager vos bonnes pratiques
- Passer à l'action par la co-construction de solutions adaptées à vos besoins

<https://www.agefiph.fr/contacter-l-agefiph/le-reseau-des-referents-handicap-rrh>

Zoom relation Agefiph/Cap emploi



A partir d'une approche globale RH :

- ✓ Conseils et accompagnement en ingénierie RH/handicap
- ✓ Outillage
- ✓ Mise en réseau (RRH)
- ✓ Appui à la professionnalisation

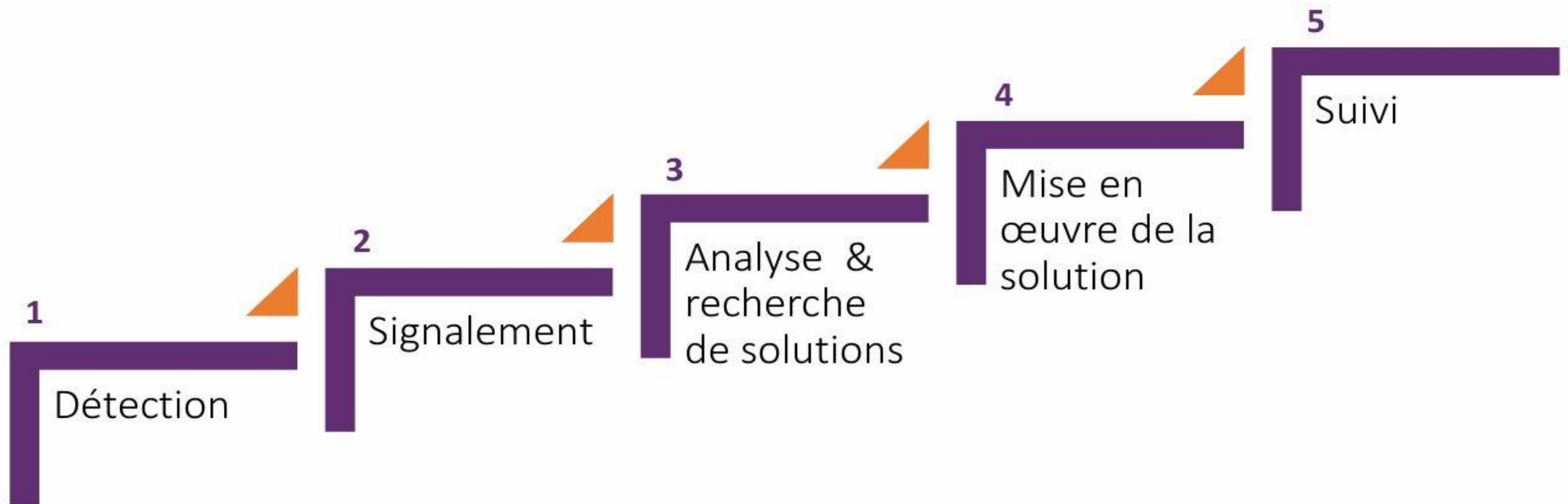
A partir d'une situation individuelle :

- ✓ Recrutement
- ✓ Maintien dans l'emploi
- ✓ Evolution professionnelle
- ✓ Transition professionnelle



Les étapes du maintien dans l'emploi

5 étapes-clés



1. Détection



1

Détection

À la reprise ou pendant
l'arrêt de travail

QUI

Le manager, le DRH, le médecin traitant, l'assistante sociale, le salarié, le médecin du travail, les collègues, les IRP, le référent ...

COMMENT

- ▶ Arrêts de travail fréquents ou prolongés
- ▶ Absences ou retards répétés
- ▶ Problèmes avec le collectif de travail
- ▶ Ralentissement du rythme de travail
- ▶ Baisse de la qualité du travail
- ▶ Signes de fatigue ou de douleurs
- ▶ Attitudes de repli sur soi
- ▶ Agressivité...

Mise en place
d'indicateurs pertinents

Indices détectables le
plus en amont possible

Lien avec les
collaborateurs en arrêt
de longue durée

2. Signalement



Intervenir le plus
en amont possible

2

Signalement

QUI

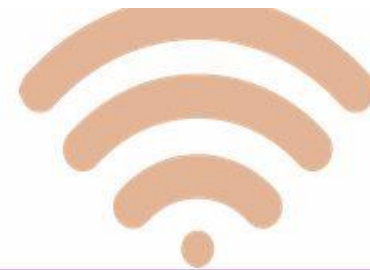
Le manager, le DRH, le médecin traitant,
l'assistante sociale, le salarié

A QUI

À tout acteur interne en mesure de
relayer au médecin du travail

COMMENT

Oralement ou de façon écrite



Visite de pré-
reprise

Éléments factuels

Transmission au
médecin du travail

3. Analyse de la situation & recherche de solutions

Commission
pluridisciplinaire

Implication du
salarié & son
manager

3

Analyse &
recherche
de solutions

COMMENT

Dialogue concerté entre le RRH, le salarié, le médecin du travail, le manager, le référent handicap, l'assistante sociale... avec l'appui possible de Cap emploi

QUOI

- ▶ La situation du salarié (restrictions au poste, compétences, besoin de formation, situation familiale et personnelle...)
- ▶ L'environnement de travail
- ▶ Les possibilités d'adaptation du poste de travail à l'état de santé de le salarié
- ▶ Le potentiel de reclassement au sein de l'entreprise

Des solutions diversifiées

**Maintien au même
poste**

Avec ou sans aménagement

**Reclassement à un
poste différent**

*Avec ou sans aménagement
Et/ou formation complémentaire*

**Reclassement dans
une autre entreprise**

**Aide à la création
d'activité**

4. & 5. Mise en œuvre de la solution & suivi

**Sensibilisation de
l'équipe en amont**

**Maintien d'un lien
privilegié avec le
salarié**



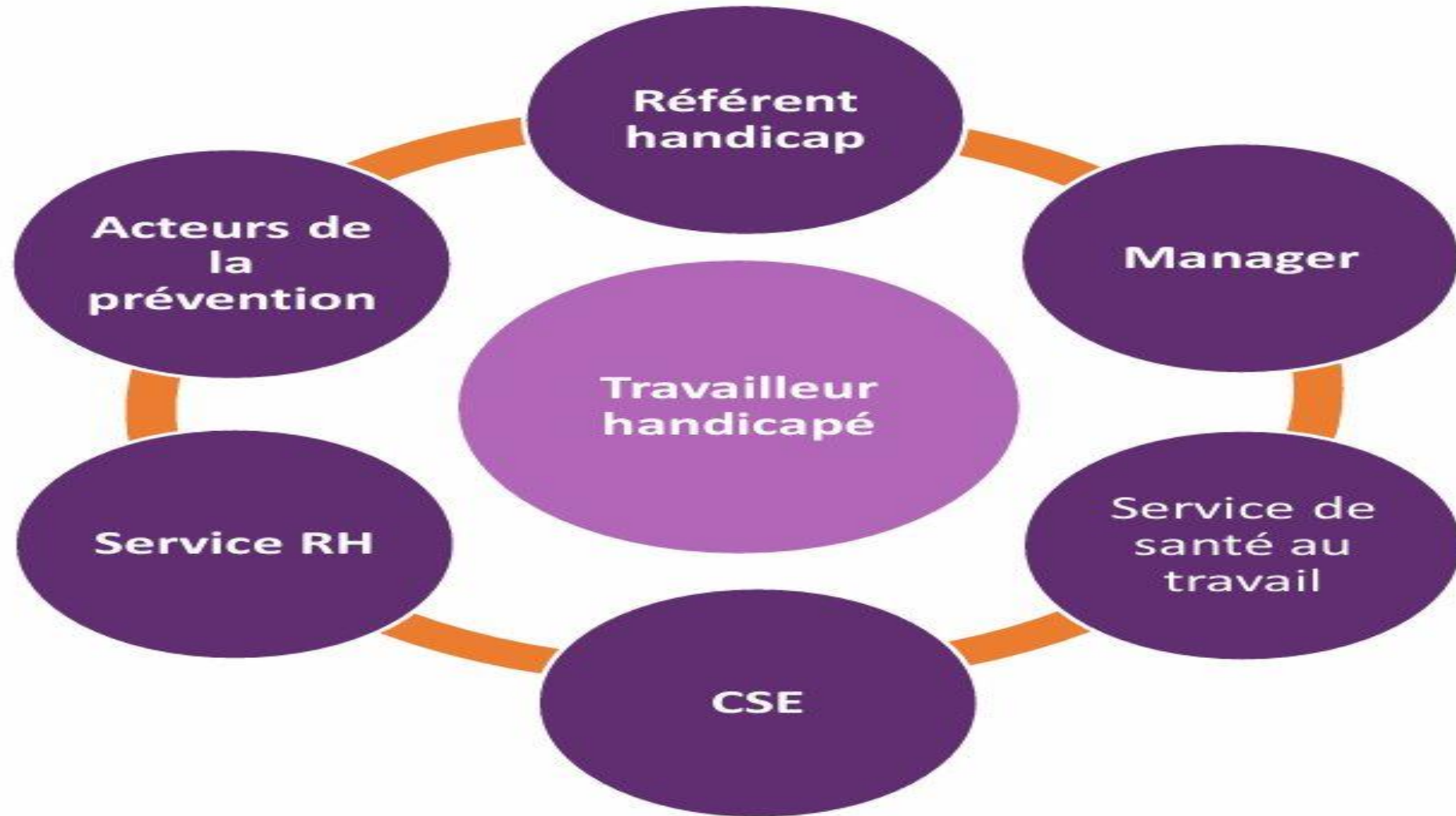
QUI

Responsable RH, référent Handicap...
Cap emploi, CARSAT...

COMMENT

Points avec les acteurs de l'équipe pluridisciplinaire,
le collaborateur et le management

Acteurs internes du maintien/prévention



Bonnes pratiques

**Impliquer tous les
acteurs dans la
définition du
processus**

**Faire valider le
processus par la
Direction**

Diffuser le processus

Vérifier l'efficacité

Acteurs externes du maintien/prévention



représentant les intérêts des
personnes handicapées ou gérant
des établissements



Les missions du cap emploi



Handicap, recrutement & maintien



Recrutement

- Analyse des postes à pourvoir et des profils recherchés
- Information sur l'incidence du handicap en situation de travail et, si besoin, mobilisation des moyens pour le compenser
- Recherche et présentation de candidats
- Mobilisation des aides financières existantes (contrats aidés par l'État, aides Agefiph...).



Intégration

- Suivi de la personne nouvellement embauchée
- Information sur les aides et dispositifs existants pour préserver l'emploi du salarié en cas d'aggravation du handicap ou d'évolution du poste de travail.



Maintien dans l'emploi

- Information et conseil sur la démarche de maintien dans l'emploi.
- Analyse de la situation et accompagnement dans la recherche et la construction de solutions adaptées.
- Mobilisation des aides et prestations techniques, humaines et financières pour la mise en œuvre de la solution de maintien.
- Suivi durable après le maintien.
- Accompagnement à la reconversion professionnelle dans le cas où le maintien dans l'emploi n'est pas possible.



Contactez le Cap emploi de votre département pour bénéficier d'un appui/accompagnement.

Les soignants : médecin traitant



Le médecin traitant :

- Prescrire l'arrêt de travail et les temps partiels thérapeutiques
- Orienter vers le médecin du travail dès que possible :
 - ✓ avant la fin de leur arrêt de travail de leur patient pour anticiper leur avenir professionnel (initier la **visite de pré-reprise**),
 - ✓ ou en dehors d'un arrêt de travail dès lors que leurs patients/salariés présentent des pathologies susceptibles d'avoir des répercussions sur leur travail (visite à la demande)
- Etablir des certificats médicaux nécessaires à la mobilisation des aides, par exemple la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou pour mobiliser une action de remobilisation pendant l'arrêt de travail (bilan de compétences, essai encadré)

Le Service de Santé au Travail (SST)



Le Médecin du travail :

- Conseiller le salarié et l'employeur
- Mener des visites médicales (à la demande/ pré reprise / reprise / suivi ou même sur le lieu de travail), pour échanger avec le travailleur sur les difficultés au travail (situation ou pathologie) et réfléchir ensemble à des solutions.
- Prescrire si besoin l'adaptation du poste de travail (avis sur le matériel et besoin éventuel d'une étude ergonomique). Il est le garant de l'adaptation du poste
- Solliciter les acteurs externes pour ouvrir le champ des possibles du maintien dans l'emploi
- Assurer un suivi des conditions du retour au travail

L'équipe pluridisciplinaire est en appui du médecin du travail (assistante sociale, ergonomiste...)

Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie

**Cellule locale de
prévention de
la désinsertion
professionnelle
(PDP)**

**Service santé au travail
Cap emploi
MDPH**

Le médecin conseil :

- Signaler les situations à risques à la CARSAT,
- Avec l'accord du salarié : initier une visite de pré-reprise ou mise en relation avec le médecin traitant, et le médecin du travail
- Se prononcer sur le bien-fondé de l'arrêt de travail et la mise en invalidité en cas de perte de capacité physique
- Statuer sur les demandes de reprise du travail à temps partiel thérapeutique

Le service de prévention des risques professionnels :

- Accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels

Les assistantes sociales de la Carsat :

- Accompagner les assurés en arrêt de travail qui risquent de perdre leur emploi du fait de leur état de santé.

Le service administratif (CPAM) :

- Faire des signalements au Service Médical et Service Social, informer les employeurs, financer des actions de remobilisation et de formation pendant l'arrêt de travail

Les chances de reclassement

Facteurs facilitants

- L'implication du salarié
- L'anticipation de l'inaptitude
- L'ouverture d'un poste sur le site / la recherche d'une solution en interne
- La coordination des différents acteurs internes et externes impliqués dans la recherche de solutions
- L'implication du manager dans la recherche de solutions
- L'ouverture du salarié au changement de poste, son potentiel d'évolution et sa mobilité
- La mobilisation de professionnels du maintien dans l'emploi (CAP EMPLOI, ergonome)
- (...)

Facteurs limitants

- La faible anticipation de l'inaptitude
- Perception négative de l'inaptitude (Management)
- La faible motivation du salarié pour être reclassé
- Les résultats de la personne inapte jugés moyens par l'encadrement
- La mobilité restreinte du salarié
- Un niveau de qualification faible pour certains postes
- (...)

Les experts en compensation du handicap



- Assurer l'accompagnement :
 - ✓ **Vers l'emploi** en vue d'une insertion professionnelle durable
 - ✓ **Dans et en emploi** : maintien, évolution professionnelle, transition professionnelle



Maisons Départementales
des Personnes Handicapées

- Accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et leurs proches, leur attribuer des droits (RQTH, AAH, Prestation de Compensation du Handicap – PCH- ...)



- Développer des aides et prestations en coopération (Cap emploi, des acteurs de la formation professionnelle et de la compensation)
- Sensibiliser les entreprises au handicap et conseiller à la création d'entreprise



Le maintien — en images

Vidéo : youtu.be/4jviDrmwd_o

Des aides pour les parcours et le maintien

Aides, prestations et services

pour accompagner les parcours professionnels des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) et leur maintien dans l'emploi.

Les aides peuvent être :

Humaines

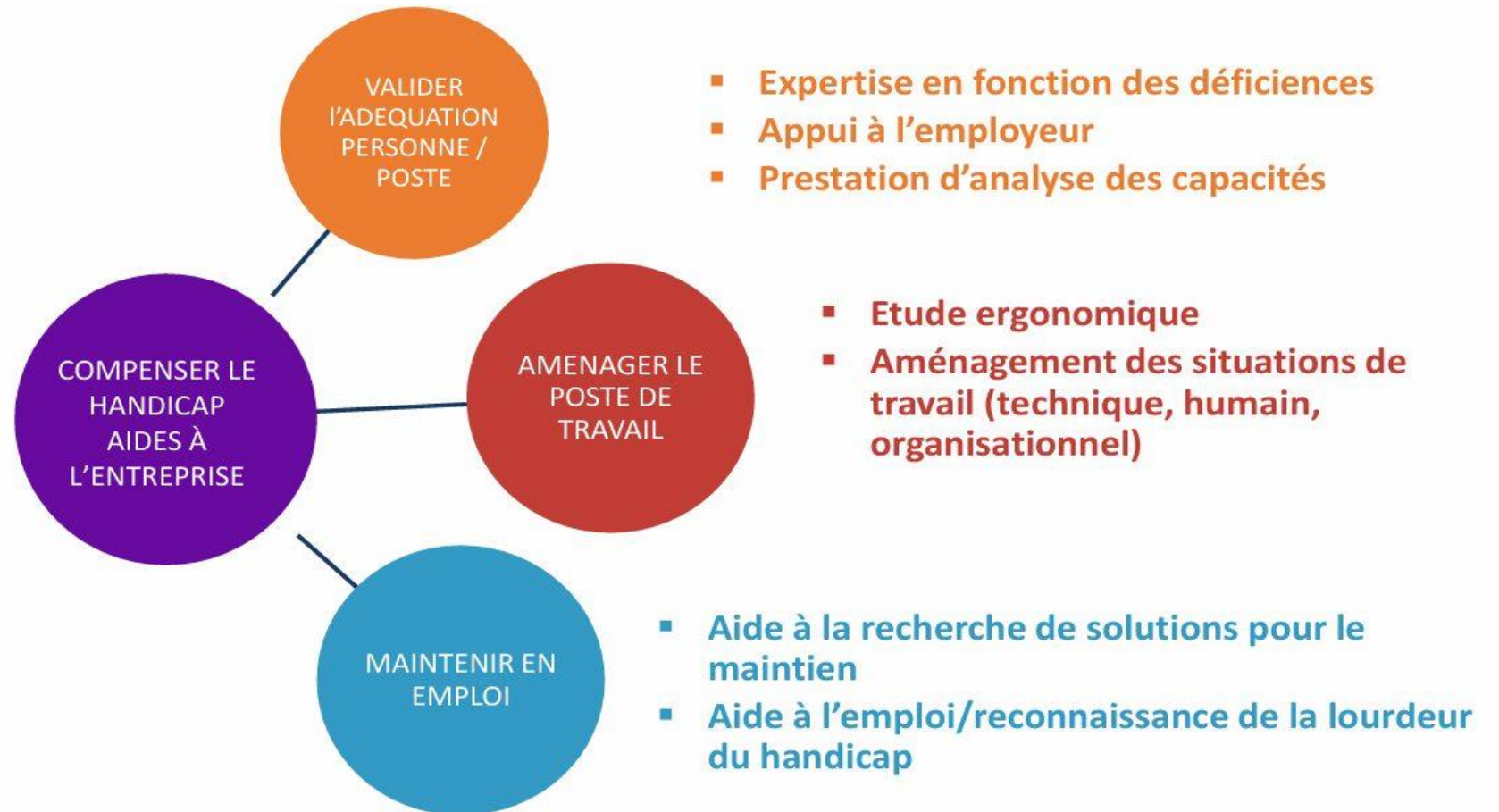
Techniques

Organisationnelles

Financières

L'enjeu est de les mobiliser au bon moment

AGEFIPH : les aides et prestations entreprises , maintien dans l'emploi



Entreprises : des aides tout au long du parcours

Des aides mobilisables à chaque étape : recrutement, intégration, aménagement, maintien.

Les besoins peuvent apparaître à différent moments : à l'arrivée dans l'entreprise, par l'évolution du poste, par l'aggravation de l'état de santé ou par un changement d'organisation

Les aides doivent être pensées comme un accompagnement continu.

BOETH : bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Financer l'aménagement d'un poste de travail, d'un collaborateur en situation de handicap



BOETH

Les aides au maintien dans
l'emploi
Accompagnement dans les
différentes transitions
professionnelles

Aide à l'aménagement des situations de
travail « AST »

Aide soutien à l'accueil, l'intégration
et/ou mobilité prof

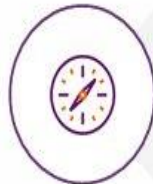
**Mobiliser Cap Emploi qui mobilisera si besoin
l'aide à la recherche de solutions pour le
maintien dans l'emploi des salariés handicapés**



L'aide a pour objectif de permettre le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée menacée dans son emploi en raison de l'inadéquation entre son handicap ou son état de santé et sa situation de travail.



L'aide est accordée pour financer des frais occasionnés par la recherche de solutions de maintien dans l'emploi (temps de concertation, réunions,...).



L'aide est forfaitaire et son montant est de 2.100 €



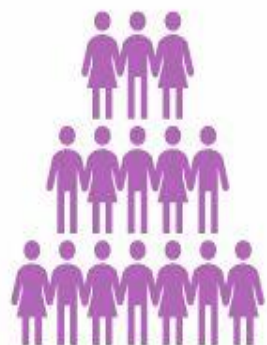
Cumulable avec les autres aides de l'Agefiph

Vos démarches de demande d'aide Agefiph sur votre espace personnel :

<https://www.agefiph.fr/articles/demarche/vos-demarches-de-demande-daide-agefiph-sur-votre-espace-personnel>

Accès à l'espace personnel : <https://aides-financieres.agefiph.fr/professionnels/s/login/>

Pour la personne, des aides pour favoriser l'autonomie



BOETH

Solutions
compensatoires
afin de favoriser
l'autonomie de la
personne handicapée

Aide technique

Aides à la mobilité

Aide humaine

Aide prothèse (s)
auditive (s)



Sécu

+

PCH

+

Mutuelle

+

Accord

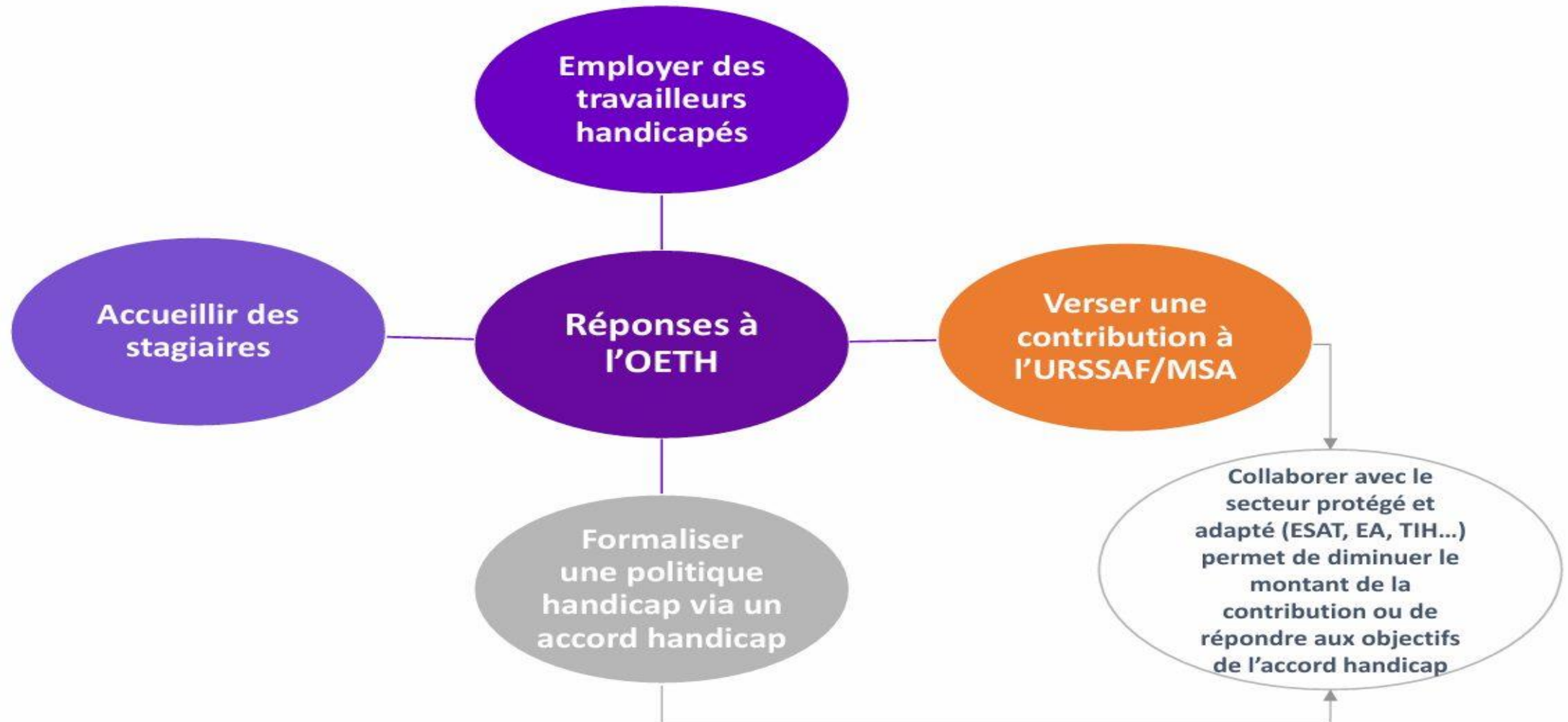
Droit
commun



Les modalités de déclaration

OETH — obligation d'emploi de travailleurs handicapés

Les modalités de réponse à l'obligation d'emploi



Modalités de déclaration



- ❑ Depuis 2020 : déclaration dématérialisée via la Déclaration sociale nominative (DSN)

Y compris pour Mayotte où la DSN a été déployée depuis le 1^{er} janvier 2022.

- ❑ Tout employeur privé, identifie en DSN les informations relatives aux BOETH, y compris les entreprises de – 20 salariés.

Seuls les employeurs ≥ 20 salariés sont soumis à l'OETH et ont des obligations contributives (si l'objectif des 6% n'est pas atteint).

Taux d'emploi à 6%
révisable tous les 5 ans

- ❑ Depuis 2020, une déclaration par entreprise et non plus par établissement autonome.



L'objectif de la réforme de 2020 était d'augmenter l'emploi direct

Des mesures transitoires ont été prévues pour les entreprises dont la contribution augmenterait

Modalités de calcul des effectifs : L'effectif d'assujettissement



Les effectifs sont **comptabilisés en moyenne annuelle**

Le décompte des effectifs (effectifs d'assujettissement et effectifs BOETH) s'effectuera désormais en appliquant les règles de droit commun utilisées pour les autres cotisations sociales, en prenant en compte l'effectif moyen annuel

Exemple :

Un salarié travaillant à 80% à compter du 1^{er} juillet année N sera comptabilisé pour 0.4

$$(0.8 \times (6/12)) = 0,4$$

Effectif en moyenne annuelle (EMA)

Temps de travail 80% = 0,8 (si temps plein = 1)

Présent 6 mois sur 12 = 6/12 (si présent toute l'année = 1)

i Les calculs des effectifs se font automatiquement grâce aux informations entrées dans la DSN

6%

L'obligation d'emploi est calculée sur la base de 6% de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise (arrondie à l'unité inférieure)

Effectif (Effectif moyenne annuelle, EMA)	Obligation d'emploi (6% arrondie à l'unité inférieure)
de 20 à 33	1
de 34 à 49	2
de 50 à 66	3
de 67 à 83	4
de 84 à 99	5
de 100 à 116	6
...	...

Modalités de calcul des effectifs : L'effectif d'assujettissement

EFFECTIF D'ASSUJETTISSEMENT (Loi PACTE, article 130-1 du CSS)

Catégories de salariés <u>inclus</u>	Catégories de salariés <u>exclus</u>
✓ Salariés titulaires d'un contrat de travail ✓ Agents ou salariés de la fonction publique ayant droit à l'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail	× Apprentis × Titulaires d'un contrat de professionnalisation × Titulaires d'un CIE et CAE × Salariés titulaires d'un CDD lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu × Salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure × Salariés temporaires (intérimaires) × Stagiaires × Gérants minoritaires de SARL et de SELARL × Présidents du conseil d'administration × Directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA et de SELAFA × Directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale × Présidents et dirigeants de SAS et de SELAS



Pourquoi des catégories sont exclus des effectifs ?

Des obligations s'imposent à l'employeur lorsque l'effectif atteint des seuils, par exemple :

- Effectif de 11 : CSE
- Effectif de 50 : règlement intérieur
- Etc...

> Ne pas compter les alternants permet de ne pas avoir d'impact sur ces seuils (donc incitatif)

> Les CDD de remplacement ne sont pas comptés car cela ferait doublon avec la personne remplacée déjà comptée dans les effectifs.

Modalités de calcul des effectifs : Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi

EFFECTIF DES BENEFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI

Catégories de salariés bénéficiaires inclus

- ✓ Salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat de travail
- ✓ Bénéficiaires stagiaires
- ✓ Bénéficiaires en PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel)
- ✓ Bénéficiaires en contrat d'alternance
- ✓ Bénéficiaires en contrats aidés : PEC
- ✓ Bénéficiaires intérimaires
- ✓ Bénéficiaires mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure
- ✓ Bénéficiaires en Service Civique



 **Déclaration mensuelle du statut des BOETH via la DSN (chaque mois)**

Pour les stagiaires et personnes en PMSMP : l'employeur renseigne en DSN la durée du stage, le titre de BOETH et une rémunération à zéro



 **Présence dans les effectifs en durée calendaire et temps de travail théorique.**

ex : x mois sur 12, x semaines sur 52, x jours sur 365 (**sans tenir compte** des jours fériés, des vacances, des absences maladie, etc...)



 **Effectifs BOETH âgés de 50 ans et plus sont multipliés par 1.5**

Modalités de calcul des effectifs : Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Exemples : calcul d'effectif BOETH



	Temps de travail théorique	X	Présence dans les effectifs *	X	Coefficient de 1,5 si 50 ans et+	=	EMA du BOETH
Un BOETH à temps plein, présent toute l'année, âgé de 48 ans.	1	X	1			=	1
Un BOETH à temps plein, présent toute l'année, âgé de 51 ans.	1	X	1	X	1,5	=	1,5
Un BOETH travaillant à 80%, arrivé le 1 ^{er} juillet en CDI, âgé de 53 ans.	0,8	X	6/12	X	1,5	=	0,6
Un stagiaire BOETH, à temps plein, présent 7 semaines, âgé de 21 ans	1	X	7/52			=	0,13
Un intérimaire BOETH, à temps plein, présent 3 mois, âgé de 30 ans	1	X	3/12			=	0,25

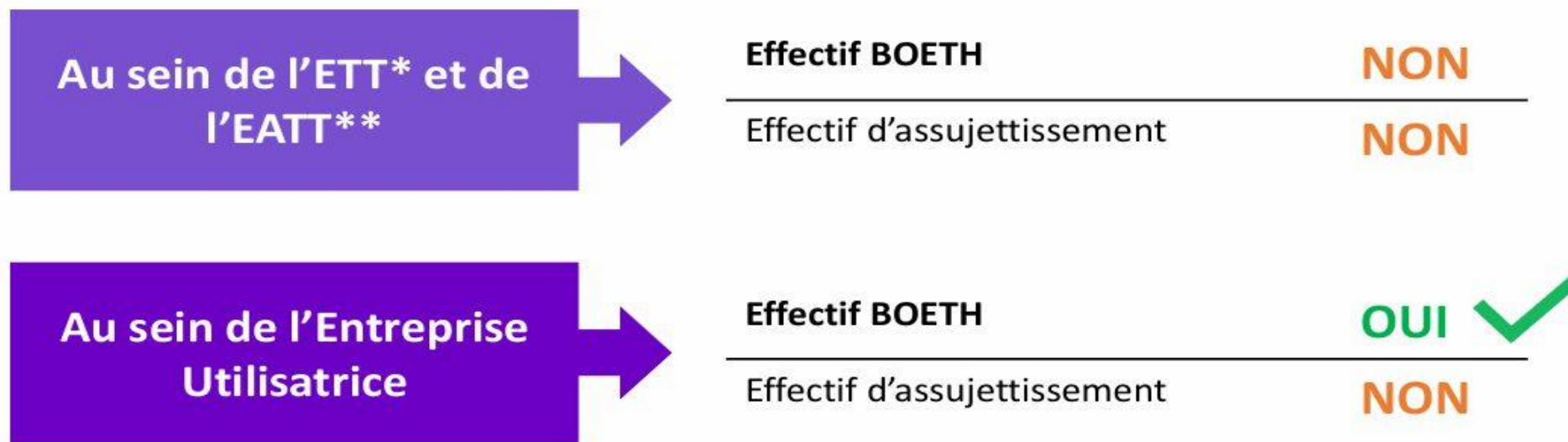


Les calculs se font automatiquement grâce aux informations entrées dans la DSN (durée du temps de travail, date d'entrée/sortie, âge, date validité titre BOETH)

* Pour le calcul de l'effectif BOETH, il faut tenir compte des dates de validité du titre de BOETH, si le titre de BOETH n'est pas valable sur toute la période de présence dans les effectifs, il faut proratiser.

Les modalités de déclaration : les intérimaires

❏ **Focus** sur la prise en compte des bénéficiaires intérimaires



* Entreprise de travail temporaire

** Entreprise Adaptée de travail temporaire

Ce schéma est identique pour les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs

Déductions de la contribution : Le recours à la sous-traitance EA/ESAT/TIH

□ Le recours à la sous-traitance auprès :

- des entreprises adaptées (**EA**),
- des établissements et services d'aide par le travail (**ESAT**),
- des travailleurs indépendants handicapés (**TIH**)
- des entreprises de portage salarial (**EPS**) lorsque le salarié porté est BOE.
- Le recours à un TIH par le biais d'une entreprise de portage salarial est déductible de la contribution annuelle, au même titre que les autres TIH

❓ La sous-traitance n'est pas comptabilisée dans le taux d'emploi (contrairement à avant 2020)
=> « Ai-je toujours intérêt à y avoir recours ? »

Les achats auprès des EA, ESAT, TIH ou EPS ne sont plus comptabilisés en tant que modalité d'acquittement de l'obligation d'emploi mais en tant que déduction de la contribution due par l'entreprise.

QUIZZ FINAL



Merci.

CGT Occitanie — Formation handicap & emploi (AGEFIPH)